

Cotrimoxazol pri UTI u starších pacientov častejšie spôsobuje nežiaduce udalosti než fluorochinolóny

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 27.05.2026

Podľa retrospektívnej štúdie z Francúzska u starších mužov s infekciou močových ciest (UTI), ktorí boli liečení **cotrimoxazolom**, bolo zaznamenané približne **dvojnásobne vyššie riziko nežiaducich udalostí (AEs)** v porovnaní s liečbou **fluorochinolónmi**. Zároveň bolo pre nežiaduce účinky častejšie potrebné liečbu ukončiť.

Ako bola štúdia robená

Výskumníci analyzovali dáta z **8 nemocníc vo Francúzsku**. Išlo o retrospektívne porovnanie pri UTI u starších mužov liečených fluorochinolónmi vs. cotrimoxazolom v období **2019 až 2023**.

Zahrnutých bolo **228 pacientov** (medián veku **85 rokov**), ktorí počas liečby vyžadovali aspoň **7 dní hospitalizačného alebo interného monitoringu**:

- **131** dostávalo fluorochinolóny
- **97** dostávalo cotrimoxazol

Primárny výsledok: výskyt aspoň jednej AEs počas liečby. Sekundárny výsledok: AEs, ktorá viedla k **ukončeniu liečby**.

Hlavné výsledky

Nežiaduce udalosti mali výrazne častejšie pacienti na **cotrimoxazole** než tí na fluorochinolónoch:

- **48,5 % vs 29,7 %** ($P = 0,006$)
- cotrimoxazol bol spojený s vyšším rizikom AEs: **adjusted OR 2,10** ($P = 0,01$)

Ukončenie liečby kvôli AEs:

- celkovo **6,2 %** pacientov
- výrazne častejšie pri cotrimoxazole: **11,3 % vs 2,3 %** ($P = 0,009$)

Najčastejšie AEs boli **akútne poškodenie obličiek (AKI)** a **metabolické poruchy**, ktoré sa vyskytovali signifikantne častejšie v skupine s cotrimoxazolom ($P < 0,05$).

Praktický význam

Autori zdôrazňujú, že výber antibiotika sa nemá opierať len o účinnosť. Pri starších, krehkých pacientoch (frailty, multimorbidita) je často kľúčová **tolerabilita** liečby, aby sa minimalizovalo liekom indukované poškodenie.

Štúdia zároveň upozorňuje, že výsledky odrážajú reálnu klinickú prax a je potrebné ich interpretovať v kontexte retrospektívneho dizajnu.

Limity

- ide o **observačnú retrospektívnu** štúdiu,
- relatívne **malý počet pacientov**,
- zaradení boli pacienti s vyššou krehkosťou a komorbiditami, čo môže obmedziť zovšeobeciteľnosť.

Zdroj: Medscape. [Kliknite sem](#).